Boletin Epidemiologico Municipio de Pereira

Índice

1 Eventos Trazadores **1**
1.1 Infección respiratoria aguda . . . 1
1.2 Circulación virus respiratorios . . . 4
1.3 Enfermedades transmitidas por vectores . . . 6
1.4 Infección Diarreica Aguda . . . 7

2 Eventos de interes en salud pública **7**
2.1 Mortalidad materno-perinatal . . . 7
2.2 Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia . . . 7
2.3 Tuberculosis . . . 7
2.4 VIH/SIDA . . . 7
2.5 Sìfilis gestacional y congénita . . . 7
2.6 Cáncer . . . 8
2.7 Defectos congénitos . . . 8
2.8 Inmunoprevenibles . . . 8
2.9 Virus nuevo (COVID-19) . . . 8

3 Vigilancia de exantematica **8**
3.1 Vigilancia Varicela en distintos grupos poblacionales . . . 8

1 Eventos Trazadores

1.1 Infección respiratoria aguda

A semana epidemiológica 8 de 2026 se notificaron un total entre consultas externa/urgencias hospitalizaciones en sala y hospitalizaciones en UCI de 405860 de las cuales el 3.02% (n= 12264) corresponden a IRA. El canal endémico muestra el evento para la semana 8 sobre el umbral estacional.

En relación a la notificación segun servicio y comparando la semana notificada del actual año con la misma semana del año anterior, se identifica un aumento en el servicio de hospitalización UCI.

Tabla 1. Comportamiento de la Infección Respiratoria Aguda segun tipo de servicio, semana epidemiológica 8

Servicio	a Sem 8/2025	a Sem 8/2026	Variacion (%)
Hospitalización Sala	634	525	-17.2
Hospitalizacion UCI	74	74	0
Consulta Externa-Urgencias	12927	11665	-9.8

Para la semana 8 la hospitalización por IRA en sala general se reporta sobre el umbral estacional. La proporción acumulada de hospitalización por IRA es de 3.5%.

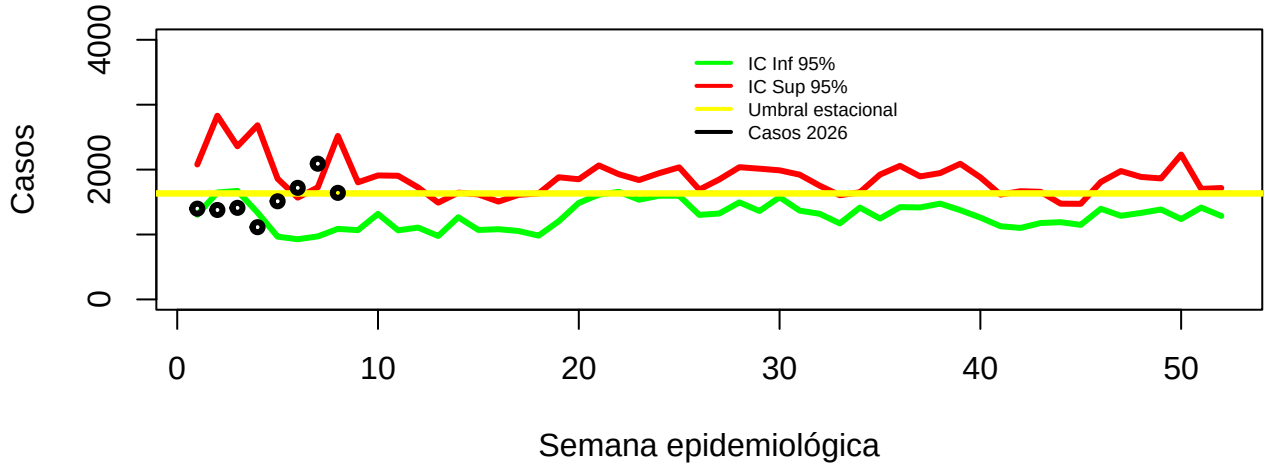


Figura 1: Canal endémico IRA , Pereira 2026 semana epidemiologica 8

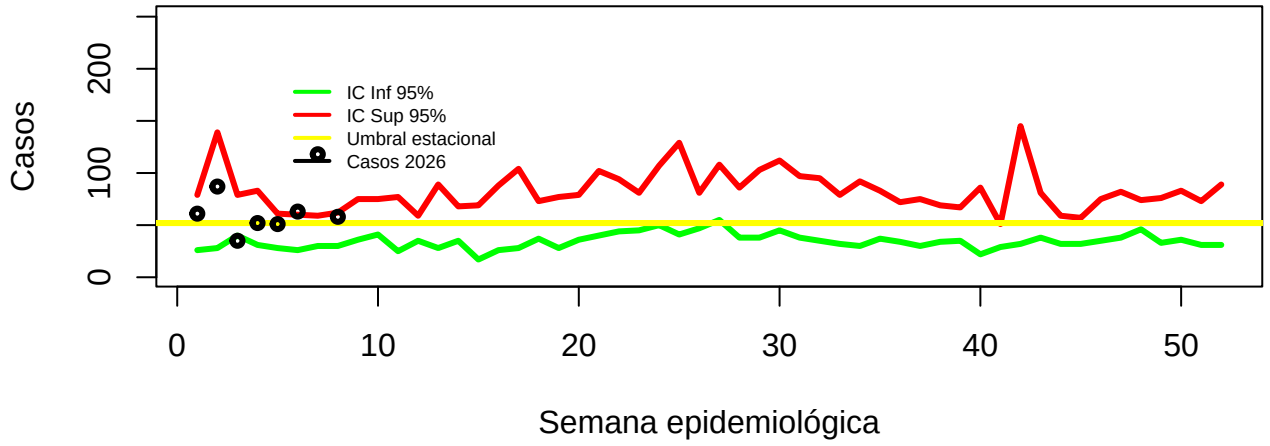


Figura 2: Canal endémico Hospitalizaciones por IRA en sala general , Pereira 2026

De igual manera en el canal endémico para la notificación por IRA hospitalizados en Unidad de Cuidados Intensivos (**UCI**) (figura 3), se encuentra sobre el umbral estacional esperado. La proporción acumulada de hospitalizaciones por IRA en UCI alcanza un 3.62%.

Edad (años)	Hosp. UCI IRA	Hosp. UCI todas las causas	% de Hosp. UCI
< 1	2	42	4.8
1	1	5	20.0
2 a 4	1	4	25.0
5 a 19	0	20	0.0
20 a 39	0	26	0.0
40 a 59	0	36	0.0
mayor e igual 60	1	117	0.9

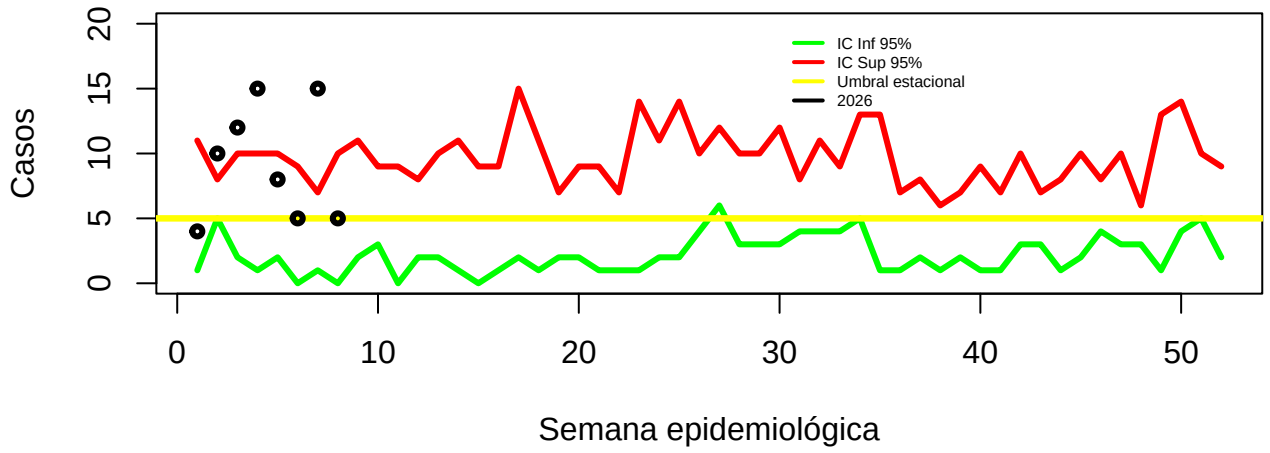


Figura 3: Canal endémico Hospitalizaciones por IRA en UCI , Pereira 2026

Por grupo de edad en la hospitalizaciones por IRA, la mayor concentración de hospitalizaciones a causa de infección respiratoria esta en el grupo menor a 5 años.

Edad (años)	Hospitalizaciones IRA	Hospitalizacion todas las causa	% de Hospitalizaciones
< 1	12	79	15.2
1	9	24	37.5
2 a 4	6	39	15.4
5 a 19	5	156	3.2
20 a 39	12	465	2.6
40 a 59	4	314	1.3

Edad (años)	Hospitalizaciones IRA	Hospitalizacion todas las causa	% de Hospitalizaciones
mayor e igual 60	10	498	2.0

En consulta externa y urgencias se han reportado de manera acumulada 388833 de consultas, donde las consultas por infección respiratoria aguda ocupan el 3%.

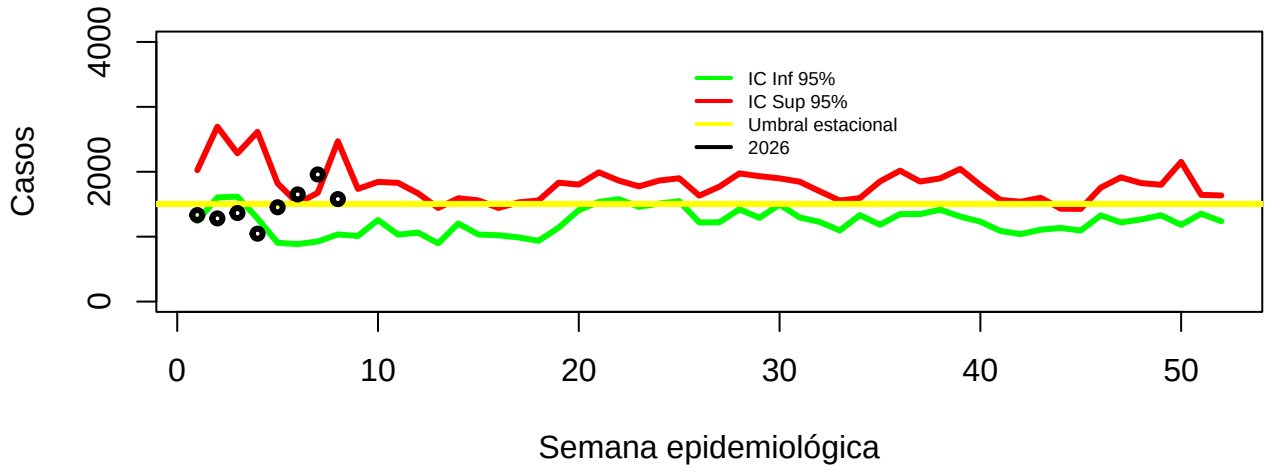


Figura 4: Canal endémico consulta externa y urgencias por IRA, Pereira 2026

En cuanto a la edad, en las consultas por IRA en servicio de consulta externa y urgencias, la proporción de consultas por IRA en cada grupo de edad se muestra en la tabla. El canal endemico general para IRA esta sobre el umbral estacional.

Edad (años)	Consultas IRA	Consulta todas las causa	% de Consultas
< 1	69	687	10.0
1	76	473	16.1
2 a 4	178	1,244	14.3
5 a 19	294	4,722	6.2
20 a 39	387	11,393	3.4
40 a 59	244	13,253	1.8
mayor e igual 60	331	19,286	1.7

1.2 Circulación virus respiratorios

A periodo epidemiologico 2 de 2026 130 muestras en el municipio, con aislamientos tanto virales como bacterianos con una positividad acumulada de 93.1% y una positividad semanal como lo muestra la **figura 5**. La incidencia de microorganismos en aislamientos virales procesado por FilmArray para el año en curso.

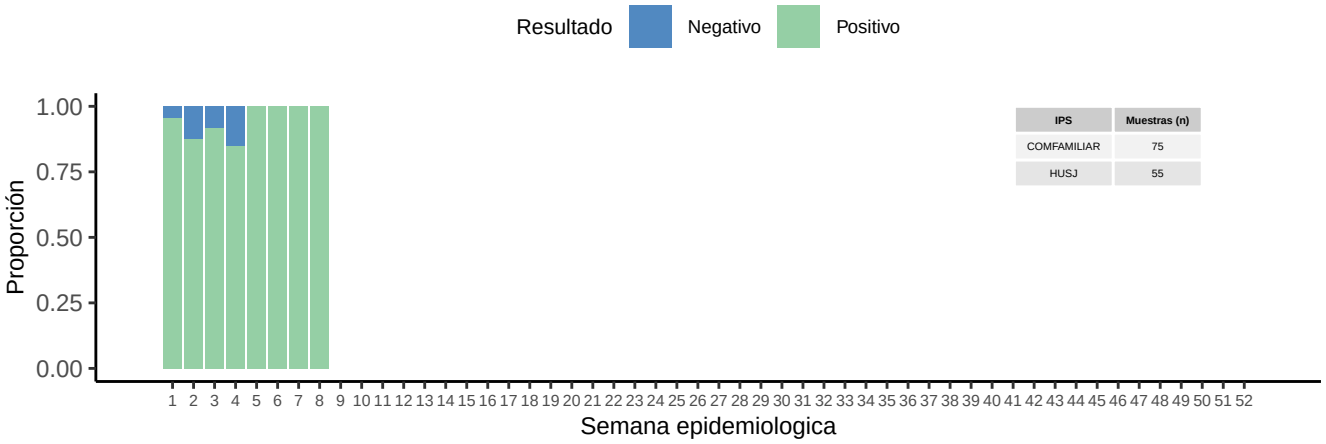


Figura 5: Positividad muestras tracto respiratorio, Pereira 2026

Durante el periodo analizado (semanas 6–5a y 7–8a), Rhinovirus se consolidó como el agente respiratorio predominante, con 52 aislamientos y una proporción de incidencia de 38,0% (IC95%: 30,26–46,31). Entre las dos semanas evaluadas se evidenció un incremento importante, pasando de 18,8% en la semana 6–5a a 39,1% en la semana 7–8a, lo que confirma una transmisión activa y en ascenso en la población muestreada.

En segundo lugar se ubicó Enterovirus, con 47 aislamientos y una proporción de incidencia de 34,3% (IC95%: 26,88–42,59). Este agente mostró un comportamiento similar al de Rhinovirus, con un aumento marcado de 18,8% a 39,1% entre ambos periodos semanales, lo que sugiere una co-circulación intensa y un incremento reciente de su participación relativa dentro de las muestras positivas.

Microorganismo	Aislamientos (n)	Prop.Incidencia (%)	IC95% inf	IC95% sup	Sem 6 - 5[a]	Sem 7 - 8[a]
Rhinovirus	52	38.0	30.26	46.31	18.8	39.1
Enterovirus	47	34.3	26.88	42.59	18.8	39.1
Influenza A	15	10.9	6.75	17.28	12.5	8.7
Adenovirus	12	8.8	5.08	14.69	12.5	13.0
Parainfluenza Virus (1,2,3)	9	6.6	3.49	12.01	0.0	13.0
VSR	9	6.6	3.49	12.01	0.0	0.0
Coronavirus	8	5.8	2.99	11.10	6.2	13.0
Influenza AH1N1	8	5.8	2.99	11.10	12.5	0.0
SARS-CoV-2	1	0.7	0.13	4.02	0.0	0.0
metaneumovirus	1	0.7	0.13	4.02	0.0	0.0

[a]Proporción de incidencia sobre las muestras procesadas en el periodo de 2 semanas

En contraste, Influenza A presentó 15 aislamientos, con una proporción de incidencia de 10,9% (IC95%: 6,75–17,28), mostrando un leve descenso de 12,5% a 8,7% entre semanas. Por su parte, Adenovirus (8,8%; IC95%: 5,08–14,69) mantuvo una participación intermedia, con ligera variación ascendente (12,5% a 13,0%). El Virus Parainfluenza 1–3 (6,6%; IC95%: 3,49–12,01) mostró incremento desde ausencia de casos (0,0%) en la primera semana hasta 13,0% en la segunda, indicando reaparición reciente en el periodo evaluado.

El Virus Sincitial Respiratorio (VSR) registró 9 aislamientos, con una proporción de incidencia de 6,6% (IC95%: 3,49–12,01), sin detección en ambas semanas evaluadas (0,0% en semana 6–5a y 0,0% en semana 7–8a), lo que sugiere ausencia de circulación activa en este corte temporal específico.

Otros virus como Coronavirus (5,8%; IC95%: 2,99–11,10) mostraron incremento de 6,2% a 13,0%, mientras que Influenza AH1N1 (5,8%; IC95%: 2,99–11,10) descendió de 12,5% a 0,0%. Finalmente, SARS-CoV-2 y Metaneumovirus presentaron proporciones bajas (0,7% cada uno), sin detección en las semanas analizadas.

En conjunto, el patrón observado refleja una circulación predominantemente sostenida y en ascenso de virus respiratorios no influenza, con claro liderazgo de Rhinovirus y Enterovirus, ambos con incrementos importantes en la segunda semana evaluada. Influenza A mantiene una circulación moderada sin tendencia ascendente marcada, mientras que VSR no evidencia actividad en el periodo analizado.

Este comportamiento sugiere un escenario de alta contribución de virus respiratorios distintos a influenza en la morbilidad respiratoria actual.

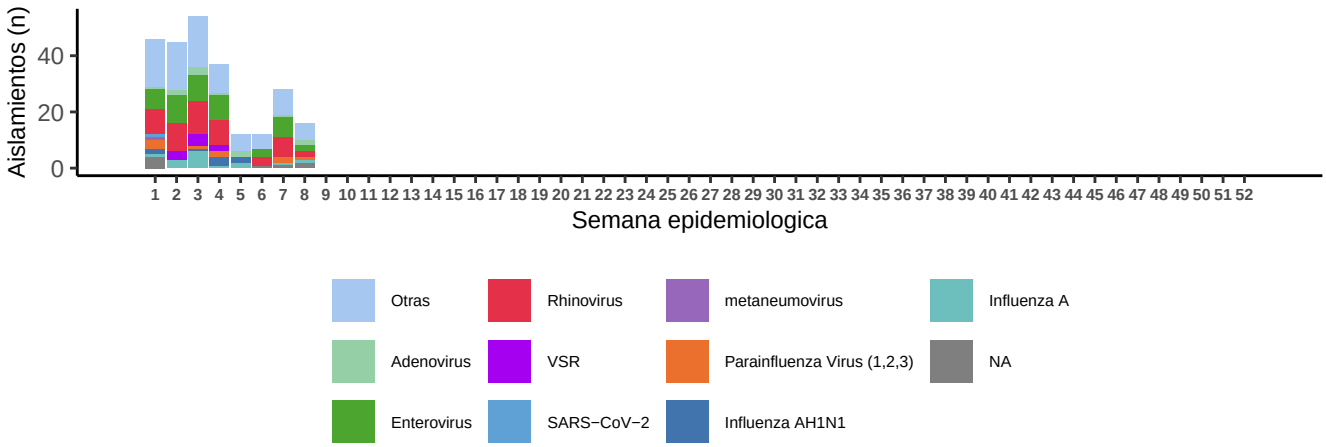


Figura 6: Circulación virus respiratorios, Pereira 2026

1.3 Enfermedades transmitidas por vectores

Para las diferentes enfermedades transmitidas por vectores el reporte de casos para esta semana y su acumulado se presentan en la siguiente tabla:

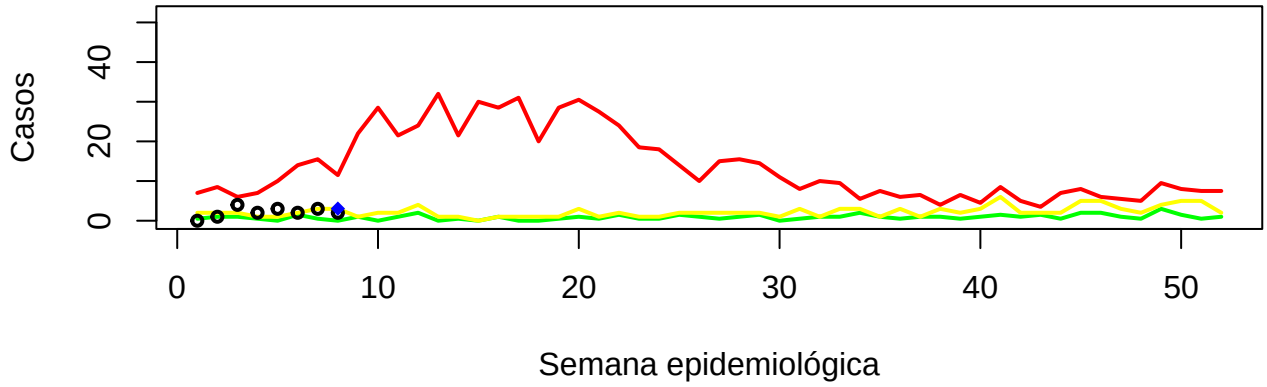


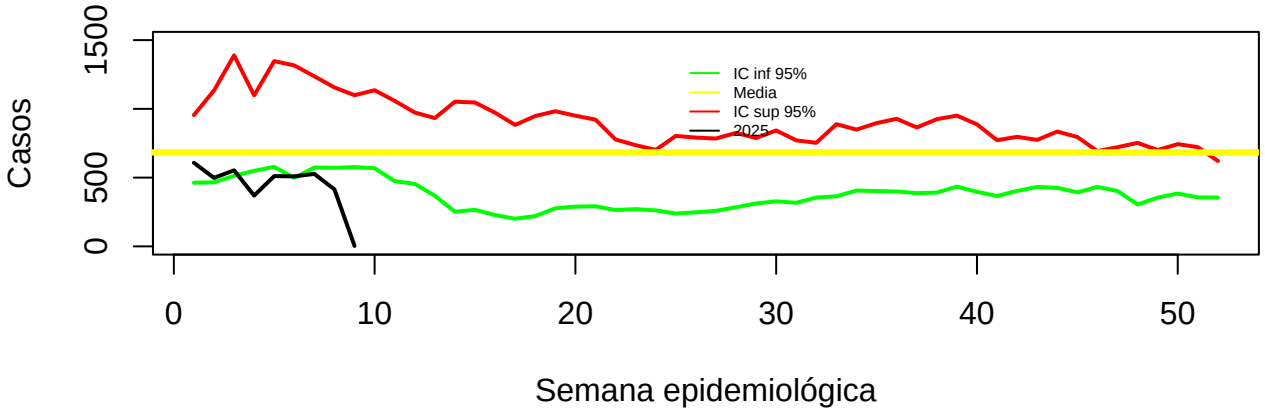
Figura 7: Canal endémico Dengue, Pereira 2026

Tabla 2. Comportamiento de la enfermedades transmitidas por vectores, semana epidemiológica 8

Evento	Semana actual	Acumulado
Dengue	2	17
Chinkunguya	0	0
Zika	0	0
Malaria	1	9

según canal endémico (figura 5) el evento dengue se mantiene en zona de brote para el año actual.

1.4 Infección Diarreica Aguda



2 Eventos de interes en salud pública

2.1 Mortalidad materno-perinatal

En la semana epidemiológica 8 de 2026 se notificaron 0 muertes perinatales; 3 casos acumulados hasta el momento.

2.2 Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia

En la semana epidemiológica 8 de 2025 se notificaron al Sivigila 41 casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia , con un acumulado hasta el momento de 420 casos.

2.3 Tuberculosis

Se notificaron al sistema de vigilancia para esta semana 5 casos de tuberculosis sensible, con un acumulado en el sivigila de 57 casos para TB sensible.

2.4 VIH/SIDA

Se han notificado 9 casos de VIH/SIDA, con un acumulado en el sivigila de 69 casos.

2.5 Sìfilis gestacional y congénita

Para esta semana se notificaron al Sivigila 2 casos de sífilis gestacional, con un acumulado al momento de 10 y casos de sífilis congénita para esta semana no se han notificado hasta el momento.

2.6 Cáncer

Entre los tipos de cáncer objeto de vigilancia en salud pública se encuentra cáncer de mama y cuello uterino. De este evento esta semana se notificaron 10 casos, con un acumulado hasta el momento de 35 casos . En Cáncer en menor de 18 años se han notificado al momento 4

2.7 Defectos congénitos

Para esta semana epidemiológica 8 de 2025 se notificaron al sistema de vigilancia 7 casos de defecto congénito. El total de casos ingresados hasta el momento son: 22 casos para defectos congénitos.

2.8 Inmunoprevenibles

Frente al evento varicela, para esta semana epidemiológica se notificaron 1 casos, con un acumulado de hasta el momento de 30.

2.9 Virus nuevo (COVID-19)

Durante este año 2026, se han notificado a semana epidemiologica 8 al sistema de vigilancia SIVIGILA un total de 4 casos leves o sin necesidad de hospitalización, para esta ultima semana epidemiologica no hay reporte de casos para COVID leve.

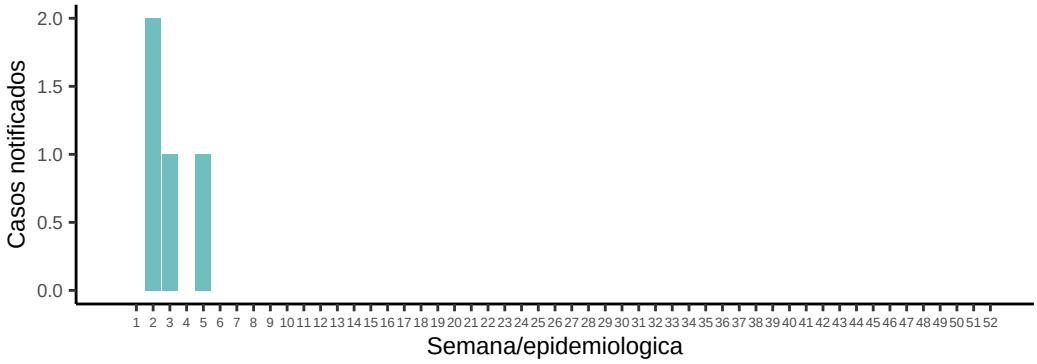


Figura 8: Notificacion semanal COVID-19, Pereira 2026

3 Vigilancia de exantematica

3.1 Vigilancia Varicela en distintos grupos poblacionales

Ante la emergencia en salud publica internacional declarada por OMS por brote multi-pais por viruela simica, se realiza vigilancia de comportamientos inusuales para varicela en diferentes grupos de edad y sexo, en este sentido para semana epidemiologica 8 no se presentan comportamientos fuera de lo esperado para ningun grupo de edad o sexo.

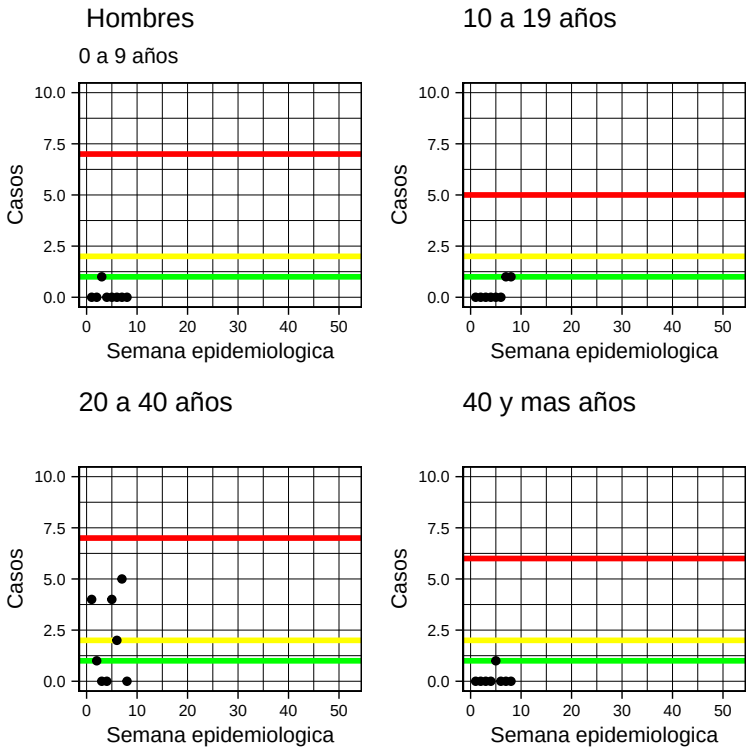


Figura 9: Comportamiento de varicela para Hombres por grupos de edad, Pereira 2026

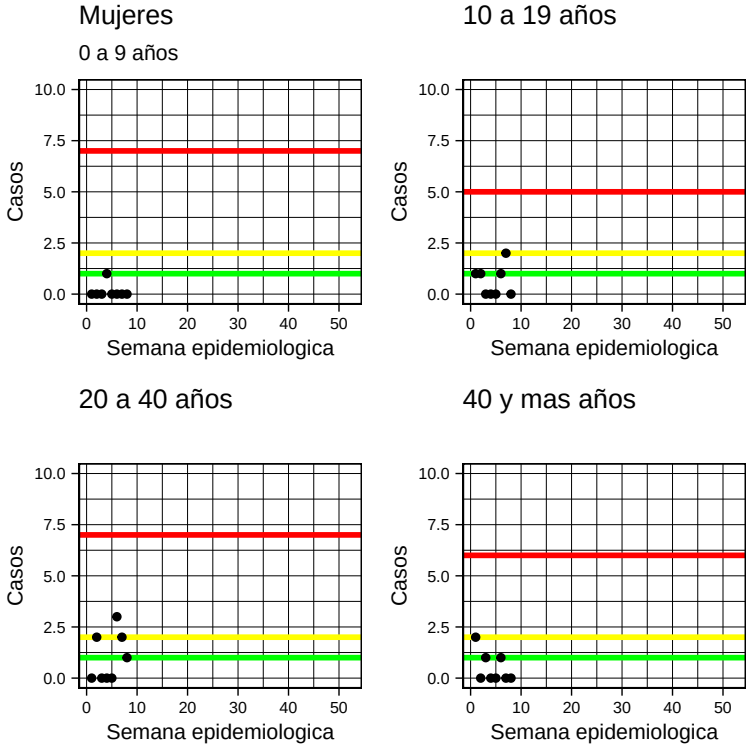


Figura 10: Comportamiento de varicela para Mujeres por grupos de edad, Pereira 2026

Cuadro 7: Comportamientos inusuales para los eventos de interes en salud pública notificados, semana epidemiologica 8 , Pereira 2024

Codigo SIVIGILA	Evento	Esperado	Observado	valor p
113	Desnutrici”n aguda en menores de 5 anos	2	3	0.18
115	Cancer en menores de 18 anos	0	0	1.00
155	Cancer de la mama y cuello uterino	8	10	0.10
210	Dengue	1	2	0.18
215	Defectos congenitos	2	7	0.00
300	Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia	49	41	0.03
330	Hepatitis a	1	0	0.37
340	Hepatitis b, c y coinfeccion hepatitis b y delta	1	2	0.18
342	Enfermedades huerfanas - raras	5	3	0.14
346	Ira por virus nuevo	26	0	0.00
348	Infeccion respiratoria aguda grave irag inusitada	0	0	1.00
352	Infecciones de sitio quirurgico asociadas a procedimiento medico quirurgico	1	0	0.37
355	Enfermedad transmitida por alimentos o agua (eta)	0	0	1.00
356	Intento de suicidio	10	13	0.07
357	Iad - infecciones asociadas a dispositivos - individual	3	1	0.15
365	Intoxicaciones	6	1	0.01
420	Leishmaniasis cutanea	0	1	0.00
455	Leptospirosis	1	2	0.18
465	Malaria	0	1	0.00
535	Meningitis bacteriana y enfermedad meningoc”cica	0	0	1.00
549	Morbilidad materna extrema	5	3	0.14
560	Mortalidad perinatal y neonatal tardia	1	0	0.37
580	Mortalidad por dengue	0	0	1.00
591	Vigilancia integrada de muertes en menores de cinco anos por infeccion respiratoria aguda - enfermedad diarreica aguda y/o desnutricion	0	0	1.00

Cuadro 7: Comportamientos inusuales para los eventos de interes en salud pública notificados, semana epidemiologica 8 , Pereira 2024

Codigo SIVIGILA	Evento	Esperado	Observado	valor p
620	Parotiditis	1	0	0.37
740	Sifilis congenita	0	0	1.00
750	Sifilis gestacional	2	2	0.27
800	Tos ferina	0	0	1.00
813	Tuberculosis	8	5	0.09
831	Varicela individual	7	1	0.01
850	Vih/sida/mortalidad por sida	9	9	0.13

Jorge Mario Estrada-Alvarez PhD. MSc. Epi

Coordiandor Eje Estrategico Vigilancia en Salud Pública

Maryluz Hincapie-Acuña MSc. Epi

Baecteriologa Epidemiologa

Viviana Trujillo

Enfermera - SIVIGILA

Angela Monsalve Esp. Epi

Enfermera Epidemiologa

Marla Alexandra Ruiz Esp. Epi

Enfermera Epidemiologa

Alcaldia de Pereira

Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social